

Información Paciente

Nombre : Elías Nicomedes Villagrán Mora
Edad : 62a 1m 21d
Dirección : Francisco De Riveros

Rut : 9.386.828-5
Fecha Nacto: 07/10/1963
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A576684
Sexo : Masculino
Teléfono : 956891972

N° Epicrisis
463863

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji
Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 24/11/2025 07:12
Fecha Egreso : 28/11/2025 11:11

Días Estadía : 4

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolro abdominal e ictericia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI: 23/11/2025

ANTECEDENTES:

Antecedentes Mórbitos: DMNIR, Hipotiroidismo, depresión.

Medicamentos: : Metformina 850mg cada 12hrs, ATV 40mg noche, Ac folico, Levotiroxina, Clozapina 250mg noche.

Cirugías: 20/05/2025 Colectistomía + CIO, cataratas ojo izq

Alergias: (-)

Tóxicos: TBQ (-) OH (-) Drogas (-)

Social: Autovalente con buena red de apoyo.

HISTORIA:

Desde el 17/11 en seguimiento con sospecha de hepatitis aguda.

Dolor abdominal, fiebre, ictericia y diarrea 3 días previos a consulta.

Antecedente de colecistectomía + CIO 20/05/2025, donde se describe ¿colangiografía intraoperatoria positiva para coledocolitiasis, se realiza abordaje transcístico con dormía, mediante múltiples intentos se logra extraccion de multiples calculos, se realiza colangiografía de salida negativa para coledocolitiasis residual¿. Bp Colecistitis crónica

Exámenes de lab previos

17/11: Hb 12.7 GB 4860 Plaq 148000, Ac láctico 30.1, PCR 9.1, Crea 0.93 BUN 12.8 ELP 139/3.31/106, BT 5.6 BD 2.98 GOT 1067 GPT 1012 GGT 625 FA 657, INR 1.09, Lipasa 187, LDH 1050,

17/11 TAC TAP: Tenues opacidades reticulares peribroncovasculares bilaterales que predominan en el lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior derecho asociadas a discretas bronquiectasias, hallazgo de probable origen residual postinflamatorio. Riñón en herradura como variante anatómica.

18/11: antiVHC (-), Antígeno de superficie VHB (-)

20/11: Hb 12.3 GB 4510 Plaq 169000, PCR 52.5, Crea 0.81 BUN 15.7 ELP 145/4.11/109, BT 2.12 BD 1.13 GOT 64 GPT 325 GGT 567 FA 548, INR 0.89

EVOLUCIÓN:

Ayer se realiza CPRE, logrando resolver coledocolitiasis residual.

Fecha Epicrisis : 28/11/2025 11:14

Fecha Última Actualización: 28-11-2025 11:14:49

Página 2 de 3

Paciente en buenas condiciones generales, no refiere dolor ni molestias, tolerando régimen liviano, tránsito de gases conservado, sin nuevos episodios de diarrea.

HD estable, sin taquicardia, afebril

Sin ictericia, bien hidratado, bien perfundido.

Abdomen blando, depresible, sensible a la palpación sin signos de irritación peritoneal

LABORATORIO

- 28/11: Hb 10.8 GB 3880 PlaQ 251000, PCR 20.3, Crea 0.67 BUN 7.3 ELP 145/3.7/113, BT 1.45 BD 0.74 GOT 59 GPT 162 GGT 1017 FA 538, INR 0.98

- 27/11: BT 1.69 BD 1.13 FA 562 GGT 964 GOT 48 GPT 200 CREA 0.7 PCR 38.4 INR 0.94 HB 10.7 HCCT 33 GB 3.41 PLAQ 239

- 26/11: Hb 10.6 GB 3450 PlaQ 181000, PCR 80, Crea 0.64 BUN 8.5 ELP 147/3.75/113, BT 2.95 BD 2.13 GOT 93 GPT 279 GGT 1081 FA 640, INR 0.96

- 25/11: Hb 10.3 GB 3300 PlaQ 159000, PCR 119, Crea 0.55 BUN 8.4 ELP 143/4.0/114, BT 6.23 BD 4.6 GOT 183 GPT 374 GGT 1111 FA 639, INR 0.92

- 24/11: Hb 12.5 GB 6450 PlaQ 202000, PCR 9.2, Crea 0.84 BUN 10.8 ELP 142/3.79/105, BT BD GOT 833 GPT 586 GGT 1439 FA 833, INR

- 23/11: Hb 12.1 GB 4.620 PlaQ 187000, Ac láctico 31.5, Crea 0.78 BUN 12.3 ELP 148/3.55/110, BT 1.54 BD 0.86 GOT 222 GPT 259 GGT 869 FA 586, INR 0.93, Alb 4.1

IMÁGENES

24/11 Eco Mege: vía biliar intrahepática dilatada. Vía biliar principal mide 1cm de diámetro con un cálculo de 1 cm en la vía biliar. Bazo, páncreas normal.

Diagnóstico de Egreso

OTRAS COLELITIASIS -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Ayer se realiza CPRE, logrando resolver coledocolitiasis residual.

Paciente en buenas condiciones generales, no refiere dolor ni molestias, tolerando régimen liviano, tránsito de gases conservado, sin nuevos episodios de diarrea.

HD estable, sin taquicardia, afebril

Sin ictericia, bien hidratado, bien perfundido.

Abdomen blando, depresible, sensible a la palpación sin signos de irritación peritoneal

Plan Post Alta

GENERAL

-Reposo relativo por 2 semanas, debe caminar evitando reposo prolongado.

-Régimen liviano por 2 semanas, evitar consumo de frituras y ricos en sal.

-Hidratarse con abundante agua, al menos 1 litro al día.

FÁRMACOS

-Mantenga medicamentos de uso habitual

-Paracetamol 500 mg. 2 comp cada 8 horas por 7 días vía oral

-Ketorolaco 30 mg. 1 comp cada 8 horas por 5 días vía oral, utilizar solo en caso de dolor que no cede con paracetamol.

-Omeprazol 20 mg. 1 comp al día en ayunas por 10 días vía oral

-Metoclopramida 10 mg. 1 comp cada 8 horas si náuseas o vómitos por 3 días.

-Ciprofloxacino 500mg. 1 comp cada 12 horas vía oral por 3 días

-Metronidazol 500mg. 1 comp cada 8 hrs vía oral por 3 días.

CONTROLES

-Control ambulatorio con cirugía hepatobiliar en 2 semanas, solicitar hora con interconsulta.

-Control en servicio de urgencias en caso de síntomas de alarma como: Fiebre ($T^{\circ} > 38^{\circ}C$), dolor abdominal que no cede con analgesia. Vómitos abundantes o SOS según estime necesario.

Fecha Epicrisis : 28/11/2025 11:14

Página 2 de 3

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Bec. Carolina Goic Vilasó

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)